

DAVITA LONDRINA · 2º SEMESTRE 2026

Longevidade na hemodiálise

Um plano para reduzir a mortalidade da nossa unidade, transformando metas de resultado em comportamentos que a equipe controla todo dia.

Duas formas de olhar uma meta

Toda meta pode ser enxergada de dois jeitos. Confundir um com o outro costuma ser a raiz do problema de quem quer melhorar e não sabe por onde.

Meta de resultado

Aonde eu quero chegar

É o destino, o número final. **Reduzir a mortalidade da unidade.**

Depende de coisas que nem sempre controlo por completo, e não diz o que fazer na segunda de manhã.

Olhar só para ela gera cobrança e pouca ação: se o mês fecha mal, não se sabe onde errou.

Meta de processo

O que eu faço para chegar lá

É o caminho: a lista de comportamentos que a equipe controla e repete todo dia.

Potássio na meta, volume controlado, fósforo e PTH ajustados, diálise adequada.

Está na nossa mão. Responde à pergunta mais importante: o que eu preciso fazer agora?

Não se muda o resultado olhando o placar

A mortalidade é o resultado. Ela melhora quando cuidamos, um a um, dos **processos que controlamos** em cada sessão.

Pense em duas pessoas que querem perder dez quilos. A que vive na balança se frustra. A que foca em caminhar todo dia, cozinhar em casa e dormir bem é quem emagrece. **A meta das duas era a mesma. Mudou onde cada uma colocou a atenção.**

Quem cuida do processo, cuida do resultado.

34

óbitos no 1º semestre de 2026

Um número alto demais para aceitarmos como normal. A mortalidade em hemodiálise no Brasil já é elevada, cerca de **16,5% ao ano** (Censo Brasileiro de Diálise, 2024). Queremos ficar muito abaixo disso.

META DE RESULTADO

**Reduzir a mortalidade
em 50% até dez/2026**

Ela tem causas que controlamos

Cada óbito evitável passa por processos que medimos e podemos corrigir. Estes são os que viram nossas metas para o segundo semestre.



Potássio

Arritmia e morte súbita, sobretudo no intervalo longo.



Volume (GPID)

Ganho acima da UF removível: sobrecarga, congestão, pressão.



Pressão arterial

Hipertrofia, insuficiência cardíaca, internação.



Fósforo · PTH · Cálcio

Calcificação vascular e risco cardiovascular.



Adequação (Kt/V)

Diálise insuficiente acumula toxinas e piora tudo.



Proteção

AAS, estatina, vitaminas, vacinação, controle de infecção.

Potássio — o que mata rápido

68%

dentro da meta hoje (K ≤ 5,5 mEq/L)

124 pacientes acima de 5,5 mEq/L. Potássio elevado no pré-diálise é gatilho de arritmia e morte súbita, o risco mais imediato da unidade.



Processo: orientação dietética a cada sessão, revisão de medicação, e busca ativa do paciente com potássio recorrente alto.

Controle de volume: o motor da sobrecarga

GPID acima da UF máxima

Ganho maior do que dá para remover na sessão

Hoje · 333 / 383

87%



50 pacientes ganham mais peso do que a UF consegue tirar, e ficam em sobrecarga. **Meta: > 90% dentro.**

Pressão arterial pré-HD

Sistólica < 160 mmHg

Hoje · 331 / 383

86%

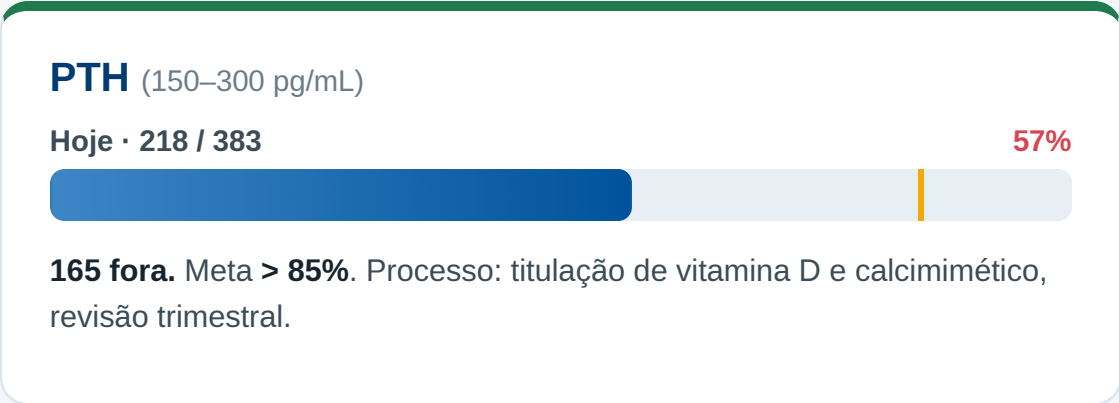
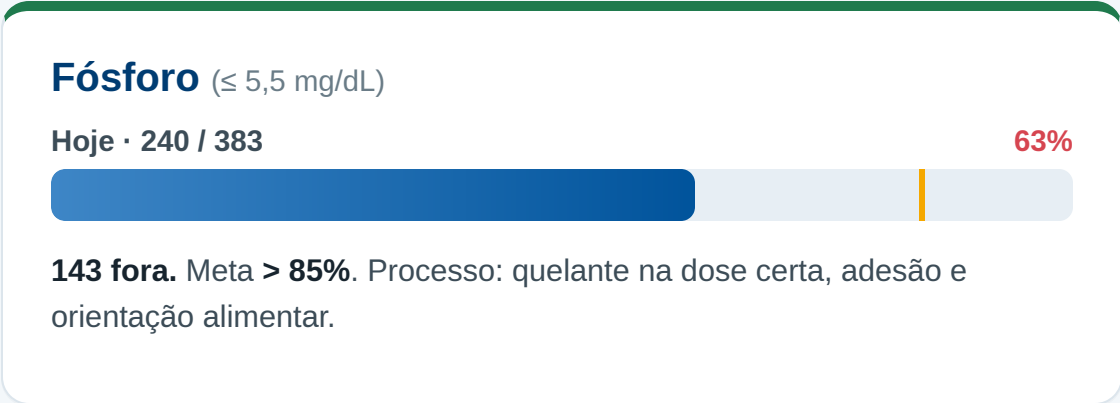


52 pacientes com sistólica ≥ 160 . **Meta: > 90% dentro.**

Diálise extra entra como ferramenta de processo do volume: indicada caso a caso, quando o excesso de peso não é removível na sessão de rotina.

Fósforo, PTH e cálcio

A maior massa de pacientes fora da meta está aqui. Controlar o distúrbio mineral reduz calcificação vascular e risco cardiovascular no longo prazo.



Kt/V — diálise que realmente limpa

84%

dentro da meta hoje (Kt/V $\geq$ 1,3)

Hoje · 322 / 383

84%

61 pacientes fora. Destes, **24 com Kt/V abaixo de 1,3** e **26 sem Kt/V medido** no mês. Medir é o primeiro processo: sem número não há ajuste.

Processo: garantir tempo prescrito, fluxo de sangue adequado, punção de bom calibre, cuidado com o acesso (cateter versus fístula) e Kt/V medido em todos.

Meta dez/2026 → > 90% dentro

Proteção e tratamento de infecção

Medidas de eficácia comprovada com meta de cobertura, e um protocolo padronizado de antibioticoterapia para não subnem sobretratar.

COBERTURA DE ROTINA



AAS

Uso conforme indicação.

> 95%



Estatina

Uso conforme indicação.

> 95%



Vitaminas

Reposição de rotina.

> 95%

PROTOCOLO DE ANTIBIOTICOTERAPIA

Infecção respiratória

7 doses

Esquema fixo de 7 doses.

Infecção de corrente sanguínea

10 doses · cultura no dia 10

Se ainda positiva, **prorrogar até 14 doses, até negativar.**

Painel de metas · base 383 pacientes

Indicador	Dentro da meta	Hoje	Progresso	Meta dez/2026
Potássio	K ≤ 5,5 mEq/L	68% (124 fora)		> 80%
Fósforo	≤ 5,5 mg/dL	63% (143 fora)		> 85%
PTH	150–300 pg/mL	57% (165 fora)		> 85%
Pressão arterial	sist. < 160 pré-HD	86% (52 fora)		> 90%
GPID	≤ UF máxima	87% (50 fora)		> 90%
Kt/V	≥ 1,3	84% (61 fora)		> 90%
AAS · Estatina · Vitaminas	uso conforme indicação	cobertura		> 95%

A barra é onde estamos; o traço dourado é a meta. Regra do semestre: **cortar pela metade o número de pacientes fora da meta**, no mesmo espírito da meta de resultado.

Reunião quinzenal de óbitos

A cada 15 dias a equipe revisa, sem culpa, os óbitos do período e pergunta: o que poderia ter sido feito para prevenir?
Cada resposta vira ajuste de processo.

1

Óbitos do período

Todos os casos das últimas duas semanas na mesa.

2

Revisão em equipe

Discussão aberta, sem culpa, focada em aprender.

3

O que era evitável?

Potássio, volume, acesso, infecção, adequação.

4

Vira ajuste de processo

Correção concreta que reflete nas metas do mês seguinte.

A conversa muda de "quem falhou" para "quais comportamentos faltaram". A primeira frase culpa; a segunda ensina, e é ela que muda o resultado no próximo período.

O resultado é a meta. O processo é o caminho. Todo dia, com cada paciente.

- **Médicos** — titulam medicação, revisam metas, conduzem a busca ativa.
- **Técnicos** — fluxo, punção, controle de peso e pressão a cada sessão.
- **Enfermagem** — garante prescrição, acesso, tempo e Kt/V medido.
- **Nutrição** — potássio, fósforo e volume começam no aconselhamento alimentar.